

ADHD, a funkcjonowanie psychospołeczne

Uzależnienia, współchorobowość, przestępczość, edukacja, praca i rodzina
synteza dowodów z metaanaliz, badań kohortowych i analiz rejestrowych

Cel i zakres

ADHD jako zaburzenie samoregulacji; dlaczego jego konsekwencje wykraczają daleko poza klasę szkolną

Kliniczny obraz ADHD obejmuje nieuwagę, impulsywność i nadruchliwość, ale jego funkcjonalne znaczenie wynika przede wszystkim z trudności w samoregulacji, planowaniu, hamowaniu reakcji i odraczaniu gratyfikacji, nawet przy prawidłowych lub wysokich zdolnościach intelektualnych.

1

Uzależnienia

rozwój, utrzymywanie się
i leczenie SUD

2

Współchorobowość

depresja, lęk, ChAD, zab.
osobowości

3

Przestępczość

nadreprezentacja i wpływ
leczenia

4

Edukacja i praca

osiągnięcia, zatrudnienie,
dochody

5

Rodzina i koszty

relacje, rodzicielstwo,
koszty społeczne

a jaką rolę odgrywa leczenie ADHD w ograniczaniu tych ryzyk?

Charakter i jakość dostępnych dowodów

Związek statystyczny / pewny efekt przyczynowy

Dowody empiryczne

- Skuteczność leków w redukcji podstawowych objawów ADHD; wiele RCT i metaanaliz sieciowych
- Krótko- i średnioterminowa poprawa funkcjonowania w warunkach kontrolowanych

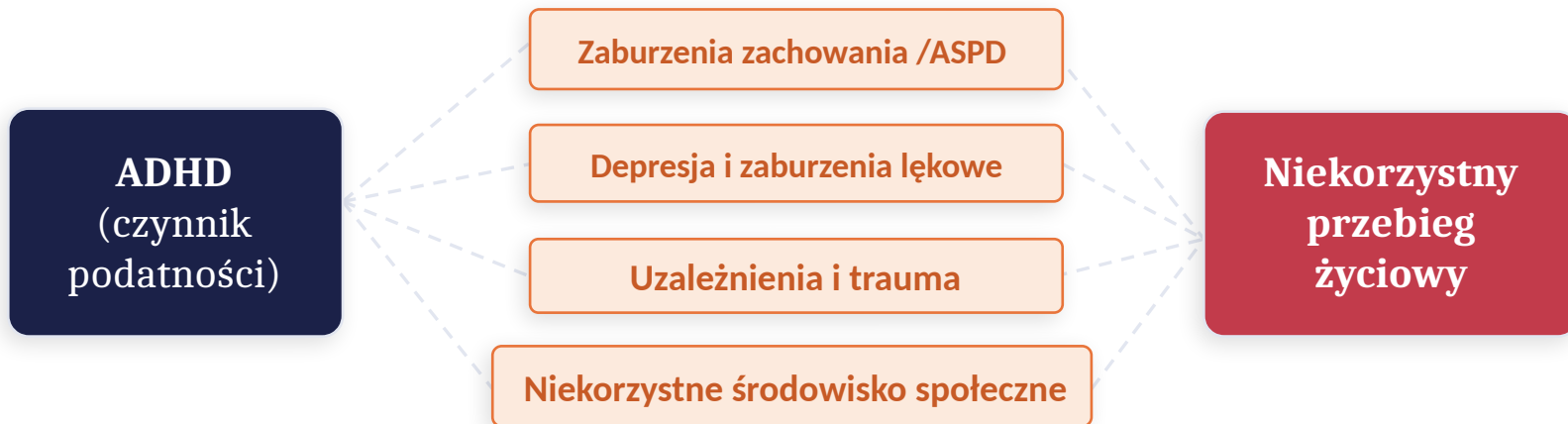
Dowody obserwacyjne

- Uzależnienia, przestępczość, śmiertelność, koszty; głównie badania rejestrowe i kohortowe
- Duża liczebność i porównania okresów leczenia/braku leczenia u tych samych osób - ale bez pełnej eliminacji czynników zakłócających

Współchorobowość (zaburzenia zachowania, depresja, trauma, osobowość antyspołeczna, warunki społeczne) może współtworzyć ryzyko i jednocześnie pośredniczyć w jego związku z ADHD

ADHD jako czynnik podatności, nie jedyna przyczyna

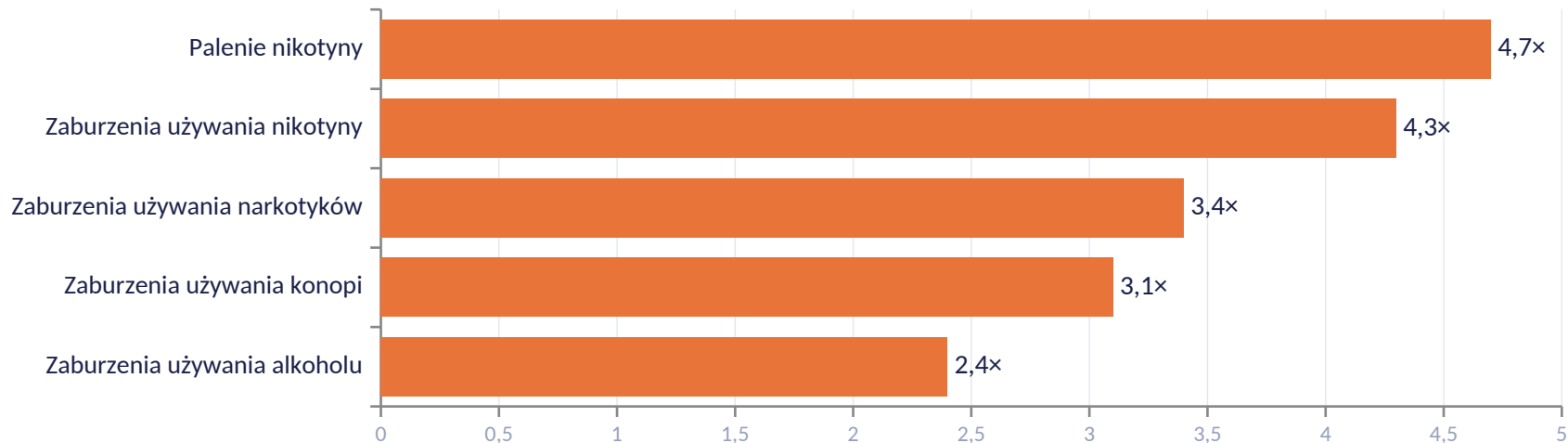
Niekorzystny przebieg życiowy wynika z nakładania się ADHD i moderatorów ryzyka



Najbardziej ostrożny wniosek: ADHD zwiększa prawdopodobieństwo cięższego przebiegu, gdyż rokowanie zależy też od współchorobowości i środowiska.

ADHD silnie zwiększa ryzyko zaburzeń używania substancji

Względne ryzyko (RR) w prospektywnych badaniach kohortowych



Źródło: opracowanie syntetyczne na podstawie Lee et al. (2011), *Clinical Psychology Review*; Charach et al. (2011), *JAACAP*.

wcześniejszy początek używania

wieszanie kilku/wielu substancji

trudniejsze leczenie
i więcej nawrotów

Sześć dróg prowadzących od ADHD do uzależnienia

Mechanizmy nie są rozłączne, mogą się więc wzajemnie wzmacniać

Mechanizm	Możliwa konsekwencja
Impulsywność	Szybsze rozpoczęcie używania i większe ryzyko nawrotu pod wpływem bodźca
Preferencja natychmiastowej nagrody	Przewaga krótkotrwałej ulgi nad odległymi korzyściami abstynencji
Poszukiwanie stymulacji	Wybieranie silnie wzmacniających zachowań i substancji
Dysregulacja emocji	Używanie substancji jako sposobu redukcji napięcia i dysforii
Dysfunkcje wykonawcze	Trudności z planem leczenia, terminami i zapobieganiem nawrotom
Współchorobowość	Kumulacja ryzyka wynikająca z depresji, zaburzeń zachowania i traumy

Hipoteza samoleczenia: krótkotrwała subiektywna ulga (napięcie, bezsenna, dysforia, chaos poznawczy) nie oznacza, że substancja „leczy” ADHD — bywa okupiona nasileniem problemów poznawczych, emocjonalnych i społecznych w dłuższej perspektywie.

ADHD utrudnia leczenie już rozwiniętego uzależnienia

Złożoność przebiegu, nie pewność każdego nawrotu

Bariery terapeutyczne

- Nieregularne uczęszczanie na terapię
- Zapominanie o wizytach
- Słaba realizacja zadań terapeutycznych
- Impulsywne nawroty
- Trudności w planowaniu sytuacji wysokiego ryzyka
- Gorsze przestrzeganie farmakoterapii

Profil kliniczny ADHD + SUD

- Wcześniejszy początek używania
- Większa liczba używanych substancji
- Więcej problemów psychiatrycznych
- Więcej problemów społecznych i prawnych

Czy farmakoterapia ADHD zwiększa ryzyko uzależnienia?

Dostępne dane nie potwierdzają wzrostu ryzyka przy prawidłowym leczeniu

✓ Brak dowodów wzrostu ryzyka

W badaniach populacyjnych leczenie stymulantami nie wiązało się ze wzrostem ryzyka SUD; część analiz wskazuje na niższą częstość zdarzeń związanych z używaniem w okresach leczenia.

Kluczowe jest rozróżnienie

Kontrolowane przyjmowanie leku ≠ pozamedyczne stosowanie, przekazywanie leków innym osobom czy zmiana drogi podania.

Strategie u pacjentów wysokiego ryzyka nadużywania

Preparaty długo działające

Leki niestymulujące

Ograniczona liczba wydawanych dawek

Monitorowanie i nadzór

Leczenie współwystępujących ADHD i SUD: model równoległy

Farmakoterapia ADHD poprawia objawy, ale rzadko wystarcza jako leczenie samego SUD



W nowszych dużych analizach rejestrowych rozpoczęcie leczenia ADHD wiązało się z niższą częstością pierwszego epizodu nadużywania substancji. Jednak obserwacyjny charakter tych wyników wymaga ostrożności interpretacyjnej.

Współchorobowość psychiatryczna jest regułą, nie wyjątkiem

Systematyczny przegląd: wyższa częstość zaburzeń nastroju, lękowych, ChAD, SUD i osobowości w ADHD

Obszar	Znaczenie kliniczne
Depresja	Zwiększa niesprawność, ryzyko uzależnień, bezrobocia i zachowań samobójczych
Zaburzenia lękowe	Mogą maskować ADHD i dodatkowo pogarszać uwagę oraz unikanie zadań
Zaburzenie dwubiegunowe	Wymaga różnicowania przewlekłych objawów ADHD od epizodów manii/hipomanii
Zaburzenia zachowania	Silnie wzmacniają związek z uzależnieniami, agresją i przestępczością
Zaburzenia osobowości	Zwiększają ryzyko niestabilności relacji, samouszkodzeń i problemów prawnych
Zaburzenia snu	Nasilają nieuwagę, drażliwość i problemy z regulacją emocji

Źródło: Choi et al. (2022), PLOS ONE — systematyczny przegląd populacji ADHD vs. bez ADHD.

Wielkości związków różnią się zależnie od populacji i kryteriów diagnostycznych — tabela przedstawia kierunek i kliniczną wagę zależności, nie uniwersalne ryzyko dla pojedynczej osoby.

Depresja, lęk i ChAD

Nakładanie objawowe wymaga uwagi na przebieg czasowy

Depresja

- Może rozwijać się wtórnie do niepowodzeń, krytyki, odrzucenia i utraty pracy
- Współwystępowanie z ADHD wiąże się z cięższym upośledzeniem i wyższym ryzykiem samobójczym

Zaburzenia lękowe

- Może wynikać z chronicznego braku kontroli nad terminami i obowiązkami
- Zarówno lęk, jak i depresja mogą pogarszać uwagę, a to komplikuje diagnostykę

Choroba afektywna dwubiegunowa

- Nakładanie objawowe: impulsywność, rozpraszalność, szybka mowa
- Kluczowy jest przebieg czasowy - ADHD przewlekłe, mania/hipomania epizodyczna

Błędne rozpoznanie ChAD u osoby z przewlekłym ADHD (lub odwrotnie) może prowadzić do niewłaściwego leczenia farmakologicznego

Zaburzenia zachowania i osobowości jako moderatory ryzyka

Największe ryzyko przestępczości i uzależnień dotyczy konkretnej konfiguracji cech

Zaburzenia zachowania → ASPD

- **Najważniejszy moderator** związku ADHD z przestępczością i uzależnieniami
- **Największe ryzyko:** wczesna agresja, uporczywe naruszanie norm
- **Późniejsze cechy antyspołeczne** najsilniej nasilają ryzyko

ADHD, a osobowość borderline

- **Wspólny mianownik:** impulsywność i dysregulacja emocjonalna
- **BPD dodaje:** utrwaloną niestabilność relacji i obrazu siebie
- **BPD dodaje:** silną wrażliwość na odrzucenie

Podwyższone ryzyko zachowań samobójczych i przedwczesnej śmierci

Ryzyko jest w dużej mierze wyjaśniane przez czynniki współwystępujące

Co podwyższa ryzyko?

- Myśli i próby samobójcze, zatrucia, wypadki
- Przedwczesna śmierć z przyczyn nienaturalnych
- Znaczną część ryzyka wyjaśniają: depresja, SUD, impulsywność, konflikty i problemy ekonomiczne

Leczenie ADHD

może obniżać częstość zdarzeń samobójczych i zgonów z przyczyn nienaturalnych (lepszą kontrolą impulsów). Jest to wynik biologicznie i psychologicznie wiarygodny, oparty na badaniach rejestrowych

Powyższe dane mają charakter epidemiologiczny i nie zastępują bezpośredniej, indywidualnej oceny ryzyka samobójczego u konkretnego pacjenta

Nadreprezentacja ADHD w populacjach penitencjarnych

Nadreprezentacja nie jest równoznaczna z przestępczością

ADHD jest znacznie częstsze w populacjach więziennych niż w populacji ogólnej. Szacunki różnią się zależnie od wieku, kraju i metody diagnostycznej, a badania oparte wyłącznie na kwestionariuszach przesiewowych zwykle wskazują wyższą częstość niż pełne badania kliniczne.

Co naprawdę decyduje o ryzyku?

Współwystępujące
zaburzenia
zachowania

Zaburzenia używania
substancji (SUD)

Ubóstwo
i bezrobocie

Niepowodzenia
szkolne

Ekspozycja na
środowiska
wysokiego ryzyka

ADHD samo w sobie nie tłumaczy przestępczości, ale wyjaśnia ją kumulacja czynników ryzyka

Farmakoterapia ADHD, a ryzyko skazania

Badanie rejestrowe (Szwecja); analiza wewnątrzsobobnicza: te same osoby w okresach leczenia i bez leczenia

Mężczyźni



HR 0,68 [0,63–0,73] → **32% niższe ryzyko**

Kobiety



HR 0,59 [0,50–0,70] → **41% niższe ryzyko**

0.4

1

brak efektu (1)

N = 25 656 osób z ADHD
porównanie tych samych osób
w okresach leczenia i bez leczenia

Konstrukcja wewnątrz-osobnicza ogranicza wpływ
stałych cech jednostki, ale nie eliminuje wszystkich
zmiennych zależnych od czasu

Edukacja: rozbieżność między potencjałem a realizacją

Trudności nie wynikają przede wszystkim z niższej inteligencji

Obserwowane konsekwencje

- Niższe oceny i większa absencja
- Częstsze powtarzanie klasy
- Większe wykorzystanie wsparcia specjalistycznego
- Wyższe ryzyko przerwania edukacji

Co naprawdę pomaga

- Farmakoterapia poprawia uwagę i hamowanie reakcji
- ...lecz wpływ na wyniki edukacyjne jest mniejszy niż na same objawy
- Najlepsze efekty: leczenie + trening organizacji + zewnętrzne terminy + dostosowania edukacyjne

Kluczowa jest rozbieżność między potencjałem, a zdolnością do systematycznej realizacji długotrwałych, wieloetapowych zadań.

Praca: bezrobocie, rotacja i prezenteizm

Prezenteizm: formalna obecność przy obniżonej wydajności

Typowe trudności w dorosłości

- Zwiększone ryzyko bezrobocia
- Częste zmiany pracy, spóźnienia
- Prezenteizm: przełączanie zadań, odwlekanie, naprawianie błędów
- Konflikty i praca poniżej kwalifikacji

ADHD nie wyklucza wysokich osiągnięć

- Środowiska dynamiczne i autonomiczne
- Szybkie informacje zwrotne
- Praca zgodna z silnymi zainteresowaniami

Ryzyko rośnie w pracy monotonnej, słabo ustrukturyzowanej, wymagającej wielomiesięcznego samodzielnego planowania

Zwiększone ryzyko wypadków i zachowań ryzykownych

Mechanizm: rozproszenie uwagi, impulsywność i poszukiwanie stymulacji

**Wypadki
komunikacyjne**

Urazy i zatrucia

**Ryzykowne zachowania
seksualne**

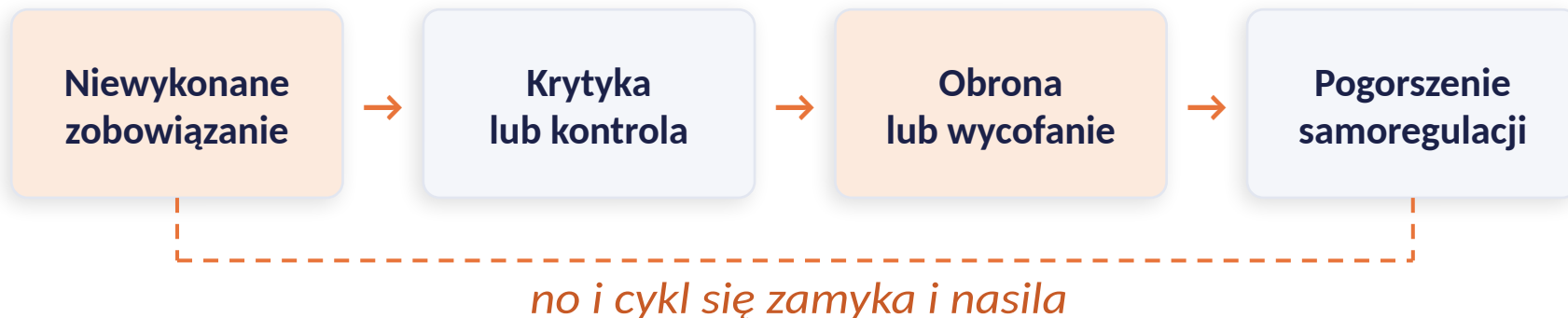
**Nieprzestrzeganie
zaleceń medycznych**

Mechanizm obejmuje rozproszenie uwagi, impulsywność, poszukiwanie stymulacji i trudności w utrzymaniu rutyn bezpieczeństwa.

Badania rejestrowe: w okresach leczenia ryzyko części zdarzeń transportowych jest niższe, choć nie dla wszystkich typów urazów wyniki są jednoznaczne.

Sprzężenie zwrotne konfliktu w relacji partnerskiej

Objaw ADHD bywa odczytywany jako obojętność albo brak szacunku



Niższa przeciętna satysfakcja relacyjna i więcej konfliktów, ale dane o rozwodach są niejednorodne. Brak jednego uniwersalnego współczynnika ryzyka rozpadu związku.

Obciążenie mentalne: partner bez ADHD często przejmuje planowanie, przypominanie i finanse, a relacja może zacząć przypominać układ rodzic-dziecko

ADHD w rodzinie: rodzic, dziecko i budżet domowy

Efekty wielu drobnych trudności kumulują się w codziennym funkcjonowaniu

ADHD u rodzica

- Park et al. (2017), 32 badania: wyższe nasilenie rodzicielstwa surowego i niekonsekwentnego
- Efekty małe, lecz kumulujące się w codziennych rutynach
- Znaczenie mają stałe rutyny i wsparcie drugiego opiekuna

ADHD u dziecka

- Większy przeciętny stres rodzicielski
- Niedobór snu, ograniczenie pracy zawodowej
- Mniejsza dostępność rodziców dla rodzeństwa i możliwe też efekty pozytywne (empatia)

Finanse rodziny

- „Podatek wykonawczy ADHD”: impulsywne zakupy, mandaty, nieterminowe opłaty
- Niewykorzystane subskrypcje, zgubione przedmioty
- Koszt wynika z trudności w przekładaniu intencji na działanie, nie z braku wiedzy

KOSZTY SPOŁECZNE

Koszty społeczne ADHD liczone są w miliardach dolarów

Wydatki bezpośrednie i pośrednie, a w dużej mierze poza systemem psychiatrycznym

122,8 mld \$

nadwyżkowe koszty społeczne ADHD
u dorosłych w USA, 2018 r.

14 092 \$

średni koszt przypadający na jedną
dorosłą osobę z ADHD rocznie

143–266 mld \$

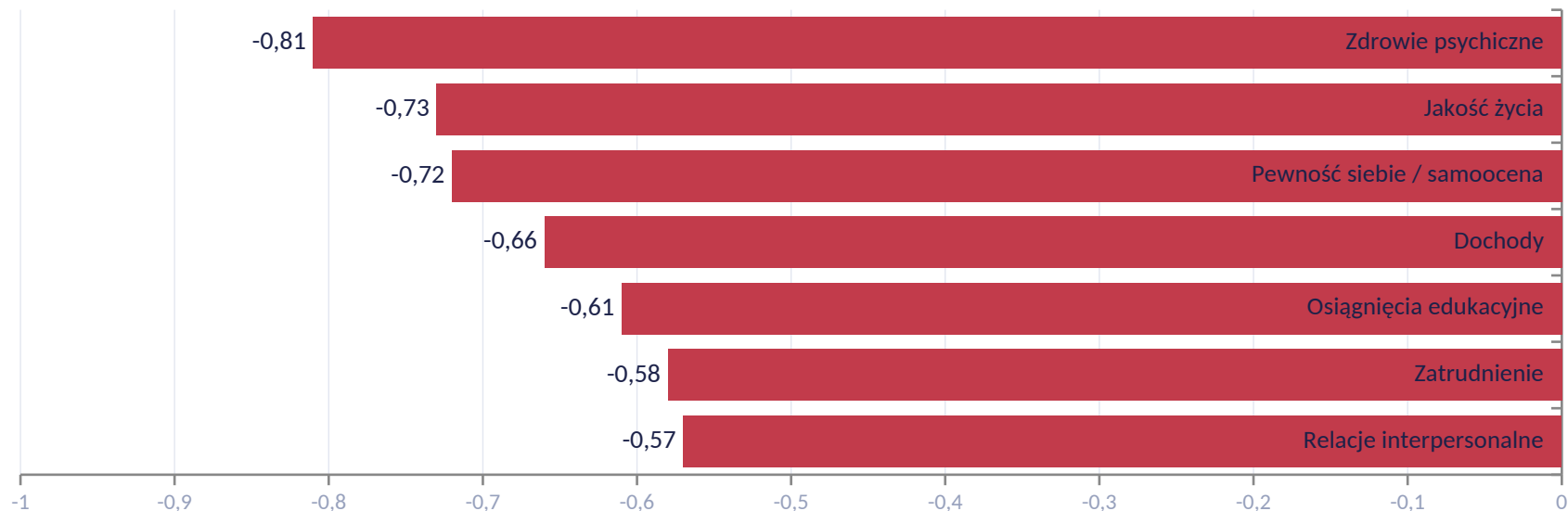
roczny koszt łączny: dzieci, dorośli
i ich rodziny (Doshi et al., 2012)

Kategoria	Przykładowe składowe
Ochrona zdrowia	Diagnoza, leki, konsultacje, hospitalizacje, leczenie SUD i urazów
Edukacja i praca	Wsparcie specjalistyczne, powtarzanie klasy, absencja, prezentyzm, bezrobocie
Rodzina, wypadki, prawo	Obciążenie opiekunów, leczenie urazów, policja, sądy, więziennictwo

Dla Polski nie istnieje obecnie równie pełne oszacowanie — mechaniczne przeliczenie kosztów USD na PLN byłoby niepoprawne metodologicznie.

Osoby z ADHD osiągają systematycznie gorsze wyniki życiowe

Faraone et al. (2021) — 86 badań, N = 2 639 438 (dzieci, młodzież i dorośli)



Cohen's d (wartości ujemne = wyniki gorsze niż u osób bez ADHD)

• interpretacja: 0,2 mały • 0,5 umiarkowany • 0,8 duży efekt

Leczenie wielomodalne: co działa, a co wymaga więcej dowodów

Najsilniejsze dowody dotyczą redukcji objawów. Dla wyników funkcjonalnych efekty są mniejsze, ale klinicznie istotne

Składowe modelu

- Farmakoterapia dobrana do profilu ryzyka
- Psychoedukacja pacjenta i rodziny
- Terapia poznawczo-behawioralna
- Trening funkcji wykonawczych
- Leczenie współchorobowości i SUD
- Interwencje rodzinne
- Dostosowania edukacyjne i zawodowe
- Leczenie zaburzeń snu

Synteza dowodów wg obszaru

Obszar	Ocena dowodów
Objawy ADHD	Silne dowody poprawy
Uzależnienia	Brak wzrostu ryzyka; możliwa redukcja
Przestępczość	Umiarkowanie silne dowody redukcji
Wypadki transportowe	Prawdopodobna redukcja
Zachowania samobójcze	Prawdopodobna redukcja (rejstry)
Edukacja	Mała-umiarkowana poprawa
Zatrudnienie / dochody	Możliwa poprawa, dane słabsze
Relacje i rodzina	Możliwa poprawa + interwencje systemowe
Recydywa	Dane ograniczone

Klasy leków i ich porównawcza skuteczność

Metaanaliza sieciowa 133 RCT, dzieci i młodzież, SMD względem placebo (ocena klinicystów)



Klasa	Mechanizm	Charakterystyka
Metylofenidat	Hamowanie wychwyty DA/NA	Szybki początek, liczne postacie uwalniania
Amfetaminy	↑ uwalnianie i ↓ wychwyt katecholamin	Najwyższa skuteczność objawowa; bezsenność
Atomoksetyna	Hamowanie transportera NA	Brak typowego potencjału nadużywania
Guanfacyna / klonidyna	Modulacja receptorów α2A	Mniejsza skuteczność; przydatne przy tikach

Źródło: Cortese, S., et al. (2018). The Lancet Psychiatry, 5(9), 727–738. Metylofenidat preferowany jako pierwsza opcja u dzieci (bilans skuteczności i tolerancji).

Monitorowanie leczenia i ograniczenia interpretacyjne

Częste działania niepożądane nie są porównywalne head-to-head między preparatami

Najczęstsze działania niepożądane

- MPH OROS:
ból głowy 22%, ↓ apetytu 15%, ból brzucha 14%
- Atomoksetyna:
nudności 26%, ból brzucha 18%, ↓ apetytu 16%
- Guanfacyna ER:
senność 38%, ból głowy 24%, zmęczenie 14%

Ograniczenia interpretacyjne

- Brak wieloletnich RCT z randomizacją do leczenia / braku leczenia
- Dane o przestępczości, śmiertelności i kosztach są w dużej mierze obserwacyjne
- Heterogeniczność ADHD: płeć, wiek, współchorobowość, środowisko
- HR / OR ≠ bezwzględne prawdopodobieństwo zdarzenia u jednej osoby

Wyniki grupowe nie pozwalają przewidzieć losu konkretnej osoby, dlatego interpretacja kliniczna pozostaje niezbędna

WNIOSKI

ADHD wymaga wczesnej, kompleksowej interwencji

- 1 ADHD silnie zwiększa ryzyko uzależnień, lecz prawidłowo prowadzona farmakoterapia tego ryzyka nie zwiększa.
- 2 **Najgorszy przebieg dotyczy konfiguracji:**
ADHD + zaburzenia zachowania/ASPD + depresja lub SUD + niekorzystne środowisko + brak leczenia
- 3 Leczenie wiąże się z niższym ryzykiem przestępczości, wypadków transportowych i zachowań samobójczych
- 4 **Koszty społeczne ADHD** liczone są w setkach miliardów dolarów rocznie
- 5 Wczesne, wielomodalne leczenie to nie tylko redukcja objawów, lecz potencjalna profilaktyka uzależnień, wypadków i marginalizacji.

Funkcjonalne konsekwencje ADHD rozciągają się od działania neuronu po budżet państwa, ale to wczesna, kompleksowa interwencja decyduje o tym, w którą stronę przechylą się ten bilans.